



Calle París cruce con Caroní, Edif. CDD, Urb. las Mercedes.

INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombre y Apellido: Yuravic Del Valle Ribero Herrades

Lugar y Fecha de Nacimiento: Venezuela, 07 de mayo de 1979.

Lugar de Residencia: Caracas.

Edad: 43 años

Sexo: Femenino.

Fecha inicial de Evaluación: 25 febrero 2022.

Consultas posteriores: 11 marzo 2022, 25 marzo 2022, 15 abril 2022, 29 abril 2022, 27 mayo 2022, 24 junio 2022, 29 julio 2022 y 26 agosto 2022

Psicólogo evaluador: Lic. Génesis González

II.- MOTIVO DE CONSULTA:

Yuravic asistió a consulta por manifestar sensación de agobio extremo, sensación de paranoia constante debido a la amenaza contra su vida y la de su esposo Adrián Chalbaud. La paciente refiere dificultades para dormir, para poder realizar actividades cotidianas con normalidad, debido al acoso y al continuo nerviosismo y refiere vivencias de ataques de pánico.

A causa de esto, se siente con extrema tristeza e impotencia al percibir que su seguridad y la de su familia está fuertemente vulnerada.

Yuravic manifiesta: “Tengo miedo todo el tiempo, estoy destrozada de verdad por dentro, vivo todo el tiempo al borde, abrumada y desesperanzada, siento terror y no sé cuánto tiempo aguante esta situación”.

III.- MATERIAL DE ESTUDIO:

Observación a través de la Escala de la Valoración de la Ansiedad de Hamilton (HAS).

- Escala de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI) (Cuestionario).
- Entrevista de Evaluación del Pánico (Entrevista estructurada).
- Lista de chequeo de estrés postraumático para el DSM-5 (PLC-5).

IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

La evaluada se presentó con ropa holgada, suéter, cabello ligeramente despeinado y visiblemente cansada.

En la Escala de la Valoración de la Ansiedad de Hamilton (HAS) la evaluada puntuó “Muy grave” en la subescala de Estado de ánimo ansioso (EAA), demostrando así que, en efecto, Yuravic padece de alto nivel de preocupación, irritabilidad y anticipación temerosa a lo peor. Así como obtuvo puntuaciones de nivel “Grave” en Tensión (T), el cual denota llanto y sobresalto fácil y sensación de inquietud. En Temores (Te) e insomnio (I), también demostró puntuaciones “Muy Grave”, siendo reporte de su dificultad para dormirse, sueño insatisfactorio y temor severo a perder su vida. Por último, demostró estado de ánimo deprimido (EAD) y la cognición (C) afectada de forma “Moderada”, específicamente por el despertar prematuro y su dificultad para concentrarse.

La Escala de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI) no demostró ningún factor ansioso estable en la paciente, es decir, no existe en la personalidad de Yuravic una predominancia ansiosa, sin embargo, se vio demostrado un estado emocional transitorio, caracterizado por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos de atención y aprensión y por hiperactividad del sistema nervioso autónomo, es decir, ansiedad. Lo cual indica que la paciente actualmente posee síntomas de ansiedad producto del ambiente que la rodea, que no son característica de su forma de ser.

La Entrevista de Evaluación de Pánico, demostró el grado de trauma de la paciente por los eventos recientes de índole político que ha vivido, tiene ciertos recursos para manejar sus estados de pánico, sin embargo, no son suficientes pues son muy sorprendidos y disruptivos en su vida cotidiana, debido a que le producen mucha inestabilidad y tristeza, el sentirse atrapada e impotente, y se descompensa.

La lista de chequeo autoadministrada por la paciente en consulta, demostró signos significativos de estrés postraumático (puntaje: 34) develando alta intensidad en sobresaltos repentinos, hiperactivación constante, problemas para concentrarse incluso pérdida de la habilidad para percibir situaciones de peligro.

V.- DIAGNÓSTICO

"Trastorno de Ansiedad Generalizado", según el DSM-5.

Se cumplen los siguientes criterios:

- A. Presencia de más de 3 meses de estos síntomas.
- B. Le es difícil controlar la ansiedad.
- C. Síntomas: fácilmente fatigada, sensación de estar atrapada, inquietud (nervios de punta), problemas de sueño e irritabilidad.
- D. Acompañado de ataques de pánico, con signos de: Sensación de dificultad para respirar o asfixia, aceleración del ritmo cardíaco, sensación de shock, mareo y miedo a morir.
- E. La ansiedad, la preocupación y los síntomas físicos han interferido en el rumbo cotidiano de su vida.
- F. Pérdida de la capacidad de funcionar en ambientes sociales y laborales que afectan negativamente sus relaciones.

VI.- PRONÓSTICO Y RECOMENDACIONES

- 1. Terapias cognitivas y de exposición consecutivas para poder lograr un mayor control de la ansiedad y los elementos traumáticos que ha vivido, y con ello, conseguir aliviar, en principio, los síntomas físicos, por ejemplo, el insomnio.
- 2. Psicoeducación de estrategias de respiración y alerta de consciencia para contrarrestar los efectos de los ataques de pánico.
- 3. Continuar con su medicación psicotrópico Alprazolam, tal como indico su médico, para ayudar con los síntomas de depresión, angustia, sueño y depresión.
- 4. Para la fecha 26 de agosto de 2022, se exhorta urgentemente que la paciente sea removida lo antes posible del ambiente del cual ha recibido amenazas reales, para preservar su vida y la de su familia.

Informe realizado por:

Lic. Génesis Andrea González

Psicólogo Clínico.

C.I. 23.709.781

Teléfono : 0416-6076376

Email: gen23709@gmail.com

